

42 - 01-La diarrhée aiguë - Pr. Samlani

La diarrhée aiguë Les objectifs pédagogiques sont argumentés les principales hypothèses diagnostiques, justifiées les examens complémentaires, argumentées l'attitude thérapeutique et planifiée, le suivi de l'évolution. Une diarrhée aiguë est définie comme étant une modification brutale de la fréquence, de l'abondance et ou de la consistance des selles. On parle d'une fréquence élevée, quand il y a plus de 3 selles par jour, le tout évoluant bien sûr depuis moins de 3 semaines.

On distingue deux types de diarrhées. La diarrhée sécrétoire, dite aussi colérimforme hydroélectrolytique. Les germes seront responsables d'un syndrome colérimforme.

Et ils vont adhérer en fait à la muqueuse, mais ne la pénètrent pas, ne la laissent pas. Ils vont agir par sécrétion d'une toxine antéropathogène, qui agit au niveau de l'intestin et provoque une hyper-sécrétion hydroélectrolytique. Les selles seront aqueuses, abondantes et le risque sera la déshydratation.

Deuxième type de diarrhées aiguës, ce sont les diarrhées antérons invasives ou gysanthériques, où il y aura une lésion de la muqueuse, puisque les germes vont adhérer à cette muqueuse et donc entraîner des lésions. Et donc les selles seront glérosanglantes, avec des débris muqueux. Et les principales complications risquent d'être l'hémorragie, la perforation, la colectasie, qui est une dilatation du côlon, et le sepsis.

Le diagnostic positif est extrêmement simple. Les diarrhées se manifesteront par des selles qui sont anormalement aqueuses. Il est important, bien sûr, de noter si ces selles contiennent des débris, du sang ou bien de la glace.

Le diagnostic différentiel est la fausse diarrhée de constipation, c'est-à-dire qu'après plusieurs jours de constipation, une débâcle peut mimer une diarrhée aiguë. Quel est le diagnostic de gravité ? C'est essentiellement la déshydratation. Il faut toujours évaluer le retentissement, la tachycardie, l'hypotension.

Le patient peut être en sueur polypnéique, il peut avoir une oligoanurie. Et les principaux facteurs aggravants sont les âges extrêmes, ça veut dire que c'est plus grave chez les enfants et chez les sujets âgés. Le diagnostic étiologique commence par un interrogatoire.

L'âge du patient, le contexte épidémiologique, là où il vit, avec qui il est en contact, la notion de voyage récent, la prise de toxiques ou bien la prise de médicaments, la notion d'hymnosuppression et bien sûr les antécédents similaires. Et il est toujours important de noter l'horaire du diagnostic. Il est important aussi de noter le type de diarrhée, la présence de selles dures nocturnes, évaluer la fréquence, évaluer la consistance, si elles sont aqueuses ou glérosanglantes et rechercher un syndrome rectal associé.

Le syndrome rectal est fait de trois symptômes. Les épreintes qui sont des contractions coliques douloureuses avec envie d'aller à la selle, les ténèsmes qui sont des tensions au niveau de l'anus et les faux besoins qui sont une envie d'aller à la selle sans réelle émission. L'examen cligne notre complet avec la recherche de signes de déshydratation mais également la palpation du ventre.

Il faut savoir s'il n'y a pas une douleur provoquée, s'il n'y a pas une défense ou même une contracture. Il est toujours important de faire les touchés pelviens mais aussi de faire le toucher rectal. Quant aux examens biologiques, ils ne sont pas systématiques.

On ne les fait pas si la diarrhée date de moins de trois jours, s'il n'est pas dysentérique, s'il n'y a pas de retentissement. Autrement dit, si la diarrhée date de plus de trois jours, s'il y a un syndrome dysentérique, s'il y a un retentissement, il faut faire des examens complémentaires. Quels sont ces examens complémentaires ? Des examens biologiques sur tout pouvoir de retentissement, c'est-à-dire un ionogramme à la recherche d'une hypocalémie, une uricratinémie à la recherche d'un retentissement rénal, une NFS, une CRP à la recherche d'une hyperleucocytose, une anémie, une augmentation de la CRP.

L'examen coproparasitologique d'Estelle est important à faire, la sérologie HIV si il y a un contexte particulier, la sérologie de Salmonella, Yersinia, Campylobacter, ou de la sérologie de Shiguel. L'examen coproparasitologique d'Estelle doit être réalisé trois jours de suite sur d'estelles fraîchement émises, toujours bien remplir la demande avec les examens, ou plutôt avec les renseignements cliniques, préciser la recherche, parce que chaque parasite a une technique qui lui est propre, et si HIV, pensez à cryptosporidiose, microsporidiose, candidose. Si retour de zone d'endémie, on peut penser à des parasites particuliers, à noter que l'entaméba histolytica est très fréquente Les coprocultures sont indiquées si le syndrome dysentérique avec rectoragie, déshydratation sévère, ou bien fièvre, supérieur à 35 degrés.

D'autres examens peuvent être importants, notamment l'endoscopie digestive, la recto-sigmoidoscopie, ou même la coloscopie, quand on a un syndrome dysentérique, il est important de réaliser cet examen, et à la recherche d'une lésion, et faire des biopsies. Un ASP, ou même une PDM abdominale, peuvent s'imposer quand on a une défense, une contracture, ou bien une suspicion de colectasie, qui est définie par un diamètre supérieur à 6 cm à l'imagerie. Les étiologies des diarrhées aiguës peuvent être scindées en cause non infectieuse et en cause infectieuse.

Les diarrhées non infectieuses sont notamment dues aux allergies alimentaires, aux colites ischémiques. Les colites ischémiques sont des atteintes ischémiques du côlon, secondaires à une diminution du débit sanguin et le débit de perfusion. Les diarrhées post-chimiothérapie, ce sont des diarrhées qui compliquent la chimiothérapie, et il faut toujours penser au début ou au mode aigu de survenue d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin.

Les étiologies infectieuses peuvent être scindées en fonction de diarrhées invasives ou de diarrhées sécrétoires. On peut retrouver des bactéries, des virus ou des parasites. Vous voyez bien que pour les diarrhées invasives, les bactéries sont dominées par la salmonellose, par la shigellose, les campylobactères, les chérichacolies antéro-invasives, les chérichacolies antéro-hémorragiques, mais également les colites post-antibiotiques qui sont dues à deux germes, le *Clostridium difficile* et le *Klebsiella oxytoca*.

Les virus responsables du diarrhée invasive sont le cytomégalovirus et les parasites sont dominés par l'amibiase, l'*Antemoeba histolytica*. Pour les diarrhées sécrétoires, les bactéries responsables sont essentiellement le choléra, les chérichacolies antéro-toxidogènes, mais également certains staph dorés. Les virus peuvent être des rotavirus et les parasites sont dominés par la Giardiase et par l'*Isospora belli*.

Un cas particulier à noter, c'est la diarrhée aiguë sécrétoire du voyageur. Généralement, c'est trois à quatre jours à l'arrivée, ou bien même au retour quand il rentre de son week-end en zone d'endémie, que le patient a des douleurs abdominales, des vomissements et la diarrhée est souvent liée à chérichacolies antéro-toxidogènes. Le traitement des diarrhées aiguës repose d'abord sur des mesures de repos, un régime sans résidus.

La réhydratation est très importante. On doit également traiter symptomatiquement par des antispasmodiques, traiter des vomissements par des antiémétiques et il faut faire très attention, on ralentit ça le transit, qui sont contre-indiqués en cas de diarrhée invasive parce qu'ils vont privilégier la pullulation du germe qui va encore plus atterrir la muqueuse digestive, être responsable de dégâts, voire même de perforations. Les antibiotiques sont prescrits en cas de diarrhée invasive et les plus utilisés sont les fluoroquinolones et les imidazoles.

Globalement, pour résumer, on différencie les diarrhées invasives qui se caractérisent par des selles qui sont peu abondantes, purulentes, parfois glirosanglantes. Cliniquement, les douleurs abdominales sont intenses, on retrouve de la fièvre, et celles-ci se secondent à des lésions de la muqueuse directes par les micro-organismes ou bien indirectes par le biais de la production de toxines. Les germes incriminés sont les salmonelloses, les shigelloses, les campylobactères, les *Yersinia*, *Echerichia coli*, entéro-invasifs ou entéro-hémorragiques, mais également *Clostridium difficile*, qui survient parfois, fréquemment, après des antibiotiques.

Le risque de ces diarrhées invasives, c'est la complication, le mégacolon toxique et le sepsis sévère. Les diarrhées hydriques, quant à elles, se caractérisent par des diarrhées qui sont très abondantes, hydriques, comme de l'eau. Pas de douleur abdominale ou bien très peu.

Les vomissements sont fréquents, la fièvre est modérée, voire absente, et le mécanisme est toxinique. C'est le germe, le vivron colérique par exemple, ou bien *Echerichia coli*, ou bien Staph, qui va sécréter une toxine. Parfois, c'est un virus qui peut envahir directement l'enterocyte.

Les complications, puisque ce sont des celles qui sont très abondantes et hydriques, sont essentiellement de l'ordre hydroélectrolytique avec une déshydratation. Et c'est là qu'il faut faire très attention aux âges extrêmes, c'est-à-dire les enfants et les sujets âgés. En conclusion de ce cours, la diarrhée aiguë est une pathologie multifactorielle.

Elle peut être extrêmement grave de par ses complications et son impact. Il est important d'évaluer correctement et de réaliser précocement une évaluation du retentissement et du terrain.